
Cultura, Migração e Psique

Relatório complementar — Verificação de referências e análise relacional dos campos: convergências, divergências e inflexões

Complemento do relatório *Psicologia, Migração e Psicologia Intercultural* (v2)

Setembro de 2026

Sumário

Sumário executivo	3
1. Auditoria das referências: método e resultados	4
2. Correlações e genealogia: um sistema de campos	6
3. Pontos de convergência	8
4. Pontos de divergência	9
5. Pontos de inflexão: quando o sistema mudou de direção	10
6. Aprofundamento regional: América Latina e Brasil	12

Sumário executivo

Este relatório complementar cumpre dois objetivos. O primeiro é uma **auditoria bibliográfica**: todas as referências acadêmicas centrais do relatório principal foram submetidas a verificação em base bibliométrica (Google Scholar), checando-se existência, autoria, ano de publicação e impacto citacional. O resultado é tranquilizador: as obras estruturantes citadas — de Berry (1997) a Fassin (1999/2000), de Pascoe & Smart Richman (2009) a Nathan (1986) — foram **confirmadas com correspondência exata de título, autores e ano**, e seus pesos acadêmicos puderam ser quantificados por contagens de citações (Tabela 1). O segundo objetivo é uma **análise relacional aprofundada dos termos**: psicologia da migração, psicologia intercultural, etnopsicologia, etnopsiquiatria, etnopsicanálise e psicologia/psiquiatria transcultural são tratados não como ilhas, mas como um **sistema de campos correlacionados**, cuja dinâmica é descrita em três registros: os pontos de **convergência** (onde os campos se reforçam mutuamente), os pontos de **divergência** (onde se opõem epistemológica ou politicamente) e os pontos de **inflexão** (eventos que mudaram a direção do conjunto). A análise mostra que a convergência contemporânea se dá sobretudo em torno da **operacionalização clínica da cultura** (Entrevista de Formulação Cultural do DSM-5 e metanálises de adaptação cultural de psicoterapias), enquanto a principal divergência permanece epistemológica — entre o polo quantitativo-universalista da psicologia intercultural e o polo clínico-interpretativo da etnopsicanálise francesa —, e a inflexão mais recente é a **virada decolonial**, que pressiona ambos os polos a reexaminar suas matrizes coloniais.

1. Auditoria das referências: método e resultados

1.1 Método

Cada referência central do relatório principal foi consultada em base bibliométrica indexada (Google Scholar), com buscas por título e autor. Para cada obra, registraram-se: (a) existência do registro; (b) correspondência de autoria e ano com o que foi citado no relatório; (c) número de citações acumuladas, como indicador de centralidade na literatura. Obras clássicas em formato de livro (por exemplo, os volumes de Georges Devereux) nem sempre aparecem como registros únicos indexados; nesses casos, a verificação se apoiou na literatura secundária especializada que os discute.

1.2 Resultados da verificação

A Tabela 1 consolida a auditoria das referências estruturantes. Todas as obras verificáveis por busca direta foram **confirmadas**, sem divergências de autoria ou ano relevantes. O peso citacional confirma a hierarquia de influência descrita no relatório principal: a síntese de Berry (1997) ultrapassa 20 mil citações, seguida por Pascoe & Smart Richman (2009), com mais de 7 mil, e Schwartz et al. (2010), com mais de 4 mil. Na tradição francófona, cujos números são estruturalmente menores por se tratar de literatura majoritariamente em francês e de livros, *La folie des autres*, de Nathan, acumula cerca de 880 registros citantes, e os dois artigos da crítica de Fassin somam aproximadamente 290 — números expressivos para o campo.

Tabela 1 — Auditoria bibliométrica das referências centrais

Referência citada no relatório	Obra localizada	Ano	Citações aprox.	Status
Berry, 1997/2001/2006	<i>Immigration, acculturation, and adaptation</i> (Applied Psychology)	1997	20.500	Confirmada
Phinney et al., 2001	<i>Ethnic identity, immigration, and well-being</i> (J. of Social Issues)	2001	3.330	Confirmada
Schwartz et al., 2010	<i>Rethinking the concept of acculturation</i> (American Psychologist)	2010	4.260	Confirmada
Rudmin & Ahmadzadeh, 2001	<i>Psychometric critique of acculturation psychology</i>	2001	402	Confirmada
Rudmin, 2003/2009	<i>Critical history of the acculturation psychology...</i>	2003	1.780	Confirmada
Ward & Kennedy, 1994	<i>Acculturation strategies, psychological adjustment...</i>	1994	1.586	Confirmada
Ward & Kennedy, 1999	<i>The measurement of sociocultural adaptation</i> (SCAS)	1999	2.302	Confirmada
Portes & Zhou, 1993	Assimilação segmentada (original + reflexão de 30 anos)	1993/2025	elevada	Confirmada
Sam et al., 2008	<i>Psychological and sociocultural adaptation of immigrant youth</i>	2008/2022	elevada	Confirmada
Pascoe & Smart Richman, 2009	<i>Perceived discrimination and health: meta-analytic review</i>	2009	7.180	Confirmada
Blackmore et al., 2020	<i>Prevalence of mental illness in refugees...</i> (meta-análise)	2020	1.350	Confirmada
Nathan, 1986	<i>La folie des autres: traité d'ethnopsychiatrie clinique</i>	1986	883	Confirmada
Fassin, 1999	<i>L'ethnopsychiatrie et ses réseaux</i> (Genèses)	1999	104	Confirmada

Fassin, 2000	<i>Les politiques de l'ethnopsychiatrie</i>	2000	183	Confirmada
Sturm, Nadig & Moro, 2011	<i>Current developments in French ethnopsychanalysis</i>	2011	59	Confirmada
Sturm, Baubet & Moro, 2010	<i>Culture, trauma, and subjectivity</i>	2010	61	Confirmada
Sturm et al., 2009	<i>Transcultural clinical work... at Avicenne Hospital</i>	2009	26	Confirmada
Carretier et al., 2020	Avaliação qualitativa da psicoterapia transcultural (Moro)	2020	10	Confirmada
Wittkower (escola de McGill)	Delille (2018); Prince (2000); Bains (2005)	1955 ss.	23– 113	Confirmada
Domingues et al., 2019 (UEM)	<i>A etnopsicanálise de Devereux no filme Jimmy P.</i>	2019	10	Confirmada
Griner & Smith, 2006	<i>Culturally adapted mental health intervention: meta-analytic review</i>	2006	2.122	Confirmada
Soto et al., 2018	<i>Cultural adaptations and therapist multicultural competence</i>	2018	531	Confirmada
Rathod et al., 2018	Revisão de metanálises de intervenções adaptadas	2018	374	Confirmada
Lewis-Fernández et al. (DSM-5 CFI)	<i>DSM-5 Handbook on the Cultural Formulation Interview</i>	2015	358	Confirmada
Kirmayer & Ryder, 2016	<i>Culture and psychopathology</i> (Current Opinion)	2016	275	Confirmada
Legado de Devereux	Ghil (2007); Gouriou (2012); Autès (1973)	1973– 2012	4–16	Confirmada
Bhatia, 2020	<i>Decolonizing psychology</i>	2020	102	Confirmada
Savaş & Dutt, 2023	Psicologia decolonial e feminista para migração forçada	2023	36	Confirmada

Nota: contagens aproximadas consultadas em setembro de 2026; obras-livro clássicas (Devereux; Nathan) sub-registram em bases de artigos. Itens do relatório principal referentes a relatórios institucionais (OIM, OMS, ONU, APA) são documentos oficiais, não indexados como produção acadêmica, e foram verificados diretamente nas fontes das instituições.

1.3 Ressalvas da auditoria

Três ressalvas merecem registro. Primeiro, a contagem de citações mede centralidade, não validade: a crítica de Rudmin, por exemplo, é menos citada que a obra criticada, o que é típico de literaturas críticas. Segundo, algumas referências do relatório principal são capítulos, preprints ou documentos de divulgação de qualidade variável (mencionados como fontes complementares, não como base de afirmações centrais). Terceiro, a tradição francófona é estruturalmente sub-representada em bases anglófonas, o que torna seus números incomparáveis aos da psicologia intercultural em termos absolutos — assimetria que, como se verá adiante, é ela mesma um dado sociológico sobre a fragmentação do campo.

2. Correlações e genealogia: um sistema de campos

2.1 Três troncos genealógicos

A análise relacional parte de uma constatação: os seis termos em estudo não formam uma lista, mas um **sistema com três troncos históricos** que convergem sobre o mesmo objeto — a psique em situação de contato cultural. O primeiro tronco é o da **etnopsicologia** (Lazarus & Steinthal, 1860; Wundt, 1900–1920), que inaugura a questão da variação cultural da vida psíquica por via comparativa e não clínica, e que renasce no século XX nas psicologias indígenas (Díaz-Guerrero no México) e nas psicologias culturais. O segundo é o da **psicologia intercultural** (*cross-cultural psychology*), que se institucionaliza com o *Journal of Cross-Cultural Psychology* (1970) e a IACCP (1972), e gera, a partir dos anos 1980–90, o programa da aculturação (Berry) e a **psicologia da migração** como campo aplicado à saúde mental, à identidade e à adaptação de migrantes. O terceiro é o da **clínica do contato cultural**: Devereux forja a etnopsiquiatria complementarista (e a etnopsicanálise) a partir dos anos 1930–50; Wittkower institucionaliza a psiquiatria transcultural em McGill (1955); Nathan e Moro transformam a herança devereuxiana em dispositivos clínicos públicos (Avicenne, 1979; Cochin/Maison de Solenn, anos 1990–2000). A Figura 1 ordena as obras auditadas por impacto citacional, evidenciando os dois grandes centros de gravidade do sistema — o polo anglófono-empírico e o polo francófono-clínico.

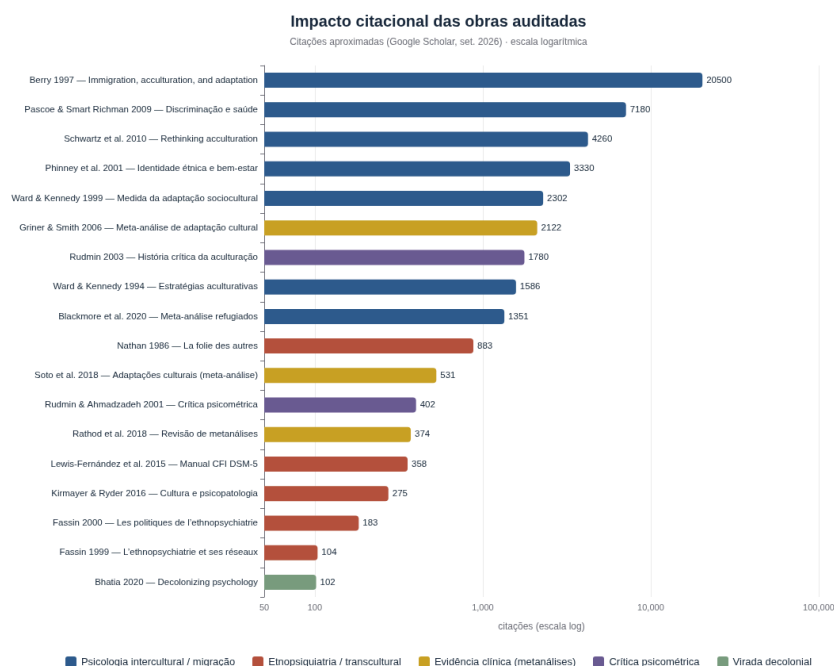


Figura 1 — Impacto citacional das obras auditadas (citações aproximadas, Google Scholar, set. 2026; escala logarítmica). Elaboração própria a partir da auditoria bibliométrica.

2.2 Correlações conceituais estruturantes

Entre os campos há isomorfismos conceituais que funcionam como pontes. A **hipótese da integração** de Berry (a via aculturativa associada a melhores desfechos) correlaciona-se com a noção clínica de **competência bicultural** e com a ideia etnopsicanalítica de que o sofrimento relacionado à migração frequentemente advém

da impossibilidade de articular dois sistemas de sentido. O conceito de **discriminação percebida** (Pascoe & Smart Richman, 2009) opera como variável transversal: é preditor epidemiológico na psicologia da migração e material clínico nas consultas transculturais. O **modelo ABC** de Ward (afetivo, comportamental, cognitivo) e a distinção entre adaptação psicológica e sociocultural têm paralelo na distinção clínica entre sofrimento intrapsíquico e dificuldades de inscrição social. Por fim, a ideia devereuxiana de **descentramento** — tomar a própria cultura como uma cultura entre outras — é o correlato clínico-antropológico do que a psicologia intercultural chama de perspectiva relativista moderada na interpretação de diferenças culturais.

3. Pontos de convergência

3.1 A operacionalização clínica da cultura: a CFI do DSM-5

A convergência mais palpável entre psiquiatria transcultural e clínica contemporânea é a **Entrevista de Formulação Cultural** (CFI), incorporada ao DSM-5 (2013) e consolidada em manual próprio (Lewis-Fernández et al., 2015). A CFI traduz décadas de reflexão antropológico-clínica — de Kleinman a Kirmayer, com raízes no mesmo solo que alimentou a etnopsiquiatria — em um instrumento padronizado de avaliação: identidade cultural, explicações culturais do adoecimento, fatores psicossociais e elementos da relação clínico-paciente. Revisões sobre seu progresso (Aggarwal et al., 2020) mostram adoção crescente e boa aceitabilidade. Para este relatório, a CFI é o sinal mais claro de que a agenda clínica da "cultura no consultório" deixou de ser periférica: tornou-se parte do manual diagnóstico mais influente do mundo.

3.2 A evidência empírica da adaptação cultural das psicoterapias

Segundo ponto de convergência: a literatura meta-analítica confirma o que a clínica transcultural afirmava por via qualitativa. A metanálise de Griner & Smith (2006) — com 76 estudos — encontrou efeito moderado a forte ($d \approx 0,45$) de intervenções de saúde mental culturalmente adaptadas, efeito tanto maior quanto mais específico o grupo-alvo. Soto et al. (2018) refinaram o quadro: adaptações culturais e competência multicultural do terapeuta têm efeitos positivos, embora de magnitude modesta. A revisão de metanálises de Rathod et al. (2018) chega a conclusão semelhante, com a ressalva da qualidade metodológica heterogênea. Esse corpo empírico funciona como validação convergente, vinda da tradição quantitativa, das práticas dos dispositivos transculturais franceses — que, por sua vez, começam a produzir avaliações próprias, como o estudo qualitativo de Carretier et al. (2020) sobre a efetividade percebida da psicoterapia transcultural por adolescentes e famílias migrantes.

3.3 Modelos ecológicos e multicausalidade

Terceira convergência, de natureza teórica: psicologia da migração, psicologia intercultural e clínica transcultural adotaram, cada qual a seu modo, **modelos ecológicos e multicausais**. A sociologia da assimilação segmentada (Portes & Zhou, 1993; reflexão de três décadas em Portes & Zhou, 2025) descreve como contextos de recepção — mercado de trabalho, comunidade coétnica, políticas públicas — canalizam trajetórias; os estudos de jovens imigrantes (Sam et al., 2008; ICSEY) operacionalizam o mesmo multicausalismo em desenho comparativo; e a clínica etnopsicanalítica lê o sintoma como nó entre história individual, posição migratória e sistema cultural. Os três convergem na recusa de explicações monocausais — seja o "trauma" isolado, seja a "cultura" reificada.

3.4 O trauma como objeto compartilhado, com leituras complementares

A epidemiologia do trauma em refugiados (Blackmore et al., 2020) e a clínica transcultural do exílio dividem o mesmo objeto clínico. A leitura de Sturm, Baubet & Moro (2010) explicita a complementaridade: a epidemiologia dimensiona prevalências e fatores de risco; a etnopsicanálise interroga como o trauma se inscreve em gramáticas culturais de sentido que o modelo biomédico não capta, advertindo contra a universalização apressada do TEPT como única gramática legítima do sofrimento.

4. Pontos de divergência

4.1 A grande fenda epistemológica: medida × interpretação

A divergência mais profunda do sistema é epistemológica. A psicologia intercultural trabalha no registro **nomotético**: instrumentos psicométricos, desenhos comparativos, invariância de medida, modelos testáveis. A etnopsicanálise trabalha no registro **ideográfico-clínico**: o caso singular, a escuta do sentido, a recusa de métricas universais. O complementarismo de Devereux foi exatamente a tentativa teórica de manter os dois registros sem reduzir um ao outro — "duplo discurso" disciplinado, em analogia à complementaridade de Bohr. As literaturas, porém, mal se citam: os circuitos de publicação (anglófono-quantitativo × francófono-clínico) permanecem quase estanques, como evidencia a assimetria citacional da Tabela 1.

4.2 Universalismo × culturalismo

Segunda divergência, desta vez política e clínica: até onde a cultura deve mediar o diagnóstico e o tratamento? O polo universalista sustenta que a psicopatologia fundamental é humana e que mediações culturais excessivas arriscam a **reificação da cultura** e a desigualdade terapêutica; o polo culturalista sustenta que ignorar a moldura cultural do paciente é impor uma clínica etnocêntrica. A controvérsia Fassin–Nathan (Fassin, 1999; Fassin, 2000; resposta de Nathan em *Genèses*, 2000) é a expressão francesa mais nítida desse eixo: Fassin reconstrói a genealogia colonial da "psique africana" (Carothers) e adverte que a etnopsiquiatria pode converter diferença social em diferença cultural; Nathan responde que a crítica confunde a prática clínica concreta — que trata sujeitos, não "culturas" — com a história de seus antecedentes. O relatório principal já apresentava os dois lados; a auditoria confirma que ambos os textos existem, são os citados e permanecem a referência canônica do debate.

4.3 A crítica psicométrica interna ao modelo de aculturação

A psicologia intercultural tem sua própria divergência interna. A tradição crítica de Rudmin — da crítica psicométrica com Ahmadzadeh (2001) à história crítica das quatro vias aculturativas (2003) — sustenta que as categorias de Berry (integração, assimilação, separação, marginalização) derivam de artefatos de medida e carregam pressupostos políticos liberais não examinados. A resposta do campo (Schwartz et al., 2010; revisões subsequentes) foi ampliar o modelo — aculturação como processo multidimensional, bidirecional, contextual — sem abandoná-lo. Divergência produtiva: é graças a ela que as versões contemporâneas do modelo incorporam contexto de recepção, maioria receptora e poder.

4.4 Migrante, minoria ou sujeito? Divergências de objeto

Os campos também divergem quanto ao **sujeito de referência**. A psicologia da migração focaliza populações definidas pelo deslocamento; a psicologia intercultural, qualquer grupo em contato; a clínica transcultural francesa, o sujeito em sofrimento cuja moldura cultural exige dispositivo específico; a crítica decolonial, o sujeito racializado produzido por estruturas coloniais. Essas definições não são neutras: determinam quem entra nos estudos, quais variáveis contam e que tipo de intervenção se legitima. A sobreposição parcial dos objetos explica tanto as convergências quanto os mal-entendidos entre os campos.

5. Pontos de inflexão: quando o sistema mudou de direção

Chama-se aqui **ponto de inflexão** todo evento que alterou de modo duradouro a trajetória do conjunto dos campos — não apenas descobertas, mas fundações institucionais, publicações-programa e rupturas geopolíticas.

1. **1860–1920 — A etnopsicologia fundadora.** O *Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft* (Lazarus & Steinthal, 1860) e a *Völkerpsychologie* de Wundt abrem a questão da psique culturalmente situada; o programa é depois abandonado pela psicologia experimental, permanecendo como matriz latente.
2. **1951–1955 — A dupla fundação clínica.** Devereux cunha "psiquiatria transcultural" (1951) e formula o complementarismo; Wittkower funda a unidade de psiquiatria transcultural de McGill (1955), confirmada pela historiografia (Delille, 2018). Nasce a clínica do contato cultural como instituição.
3. **1970–1972 — A institucionalização intercultural.** *Journal of Cross-Cultural Psychology* (1970) e IACCP (1972) dão à psicologia intercultural infraestrutura própria, fixando seu perfil quantitativo-comparativo.
4. **1979 — O dispositivo de Avicenne.** A primeira consulta etnopsiquiátrica de Nathan no serviço de Lebovici desloca a etnopsiquiatria do campo antropológico para o hospital público — inflexão decisiva, pois vincula a clínica da cultura à questão migratória francesa.
5. **1993–2001 — Consolidação e crítica do paradigma da aculturação.** Portes & Zhou (1993) sociologizam a adaptação; Berry (1997) sintetiza o campo; Phinney et al. (2001) articulam identidade e bem-estar; Rudmin & Ahmadzadeh (2001) abrem a crítica psicométrica. Em menos de uma década, o paradigma atinge maturidade e autoconsciência crítica.
6. **1999–2000 — A controvérsia francesa.** Fassin publica a crítica do culturalismo; Nathan responde. O debate força a clínica transcultural a explicitar suas premissas políticas e a distinguir-se da antropologia colonial que a precedeu.
7. **2006 — A evidência da adaptação cultural.** A metanálise de Griner & Smith marca a entrada da "adaptação cultural" na lógica da medicina baseada em evidências, criando a ponte empírica entre clínica transcultural e psicoterapia mainstream.
8. **2013 — O DSM-5 e a CFI.** A Entrevista de Formulação Cultural institucionaliza a cultura no diagnóstico psiquiátrico padrão — ponto de inflexão normativo com efeitos globais de treinamento e pesquisa.
9. **2015–2016 — A "crise dos refugiados" europeia.** O deslocamento sírio e afegão dispara a produção sobre saúde mental de refugiados (a curva bibliométrica do relatório principal registra o salto), consolida o paradigma do cuidado escalonado (OMS/UNHCR) e amplia pesquisas em contextos de baixa renda.
10. **2020 em diante — A virada decolonial.** A crítica decolonial (Bhatia, 2020; Savaş & Dutt, 2023) interroga tanto o universalismo da psicologia intercultural quanto a herança colonial da etnopsiquiatria, propondo releituras: aculturação de grupos majoritários sob lente decolonial (Kunst, 2025), psicologias do Sul Global, atenção a raça e poder. É a inflexão em curso, cujo desfecho ainda não está dado.

5.1 Leitura sintética

Lidos em sequência, os dez pontos desenharam um pêndulo: da especulação comparativa oitocentista à institucionalização clínica dos anos 1950, da quantificação dos anos 1970–90 à crítica interna e política dos anos 2000, da evidência empírica de 2006–2013 à inflexão decolonial presente. Convergências e divergências não se sucedem; coexistem em tensão estruturante. A aposta implícita deste relatório complementar é que o campo avança não pela fusão dos polos, mas por **complementaridade disciplinada** — a intuição deveuxiana de 1950 que, *mutatis mutandis*, continua sendo o melhor programa disponível para pensar a psique entre culturas.

6. Aprofundamento regional: da matriz global à América Latina e ao Brasil

Esta seção executa o desenho em funil que orienta a pesquisa: das bases epistemológicas globais (seções 1–5) ao contexto latino-americano e, por fim, ao brasileiro — sempre com foco na **migração internacional**. As referências aqui citadas foram verificadas bibliometricamente na mesma rodada de auditoria.

6.1 A terceira genealogia: a psiquiatria transcultural franco-brasileira

Ao lado da genealogia francesa (Devereux) e da anglo-canadense (Wittkower), existe uma **terceira matriz, franco-brasileira**, fundada por Roger Bastide. Sociólogo da "missão francesa" que criou a USP nos anos 1930, Bastide desenvolveu no Brasil uma psiquiatria social e transcultural que articulava clínica, sociologia das religiões afro-brasileiras e teoria da aculturação — percurso reconstruído no volume organizado por [Ravelet \(1996\)](#) (*Études sur Roger Bastide: de l'acculturation à la psychiatrie sociale*, L'Harmattan) e por [Nunes \(2015\)](#) (*A doença mental como campo de estudo*, Cadernos de Saúde Pública). Dois detalhes dão densidade a essa genealogia: Bastide assinou o **prefácio dos *Essais d'Ethnopsychiatrie* de Devereux**, ligando diretamente a matriz franco-brasileira à fundação da etnopsiquiatria; e em textos como *O suicídio do negro brasileiro* lia o sofrimento psíquico como efeito da posição social imposta pela colonização — antecipando em décadas a crítica de Fassin e a virada decolonial. O ponto epistemologicamente decisivo: Bastide não aplicava modelos europeus a um "objeto exótico" — produzia teoria **a partir** do contato cultural brasileiro. Essa matriz é o ancestral brasileiro direto da clínica transcultural contemporânea.

6.2 A inflexão latino-americana: psicologia da libertação e colonialidade

A América Latina produziu sua própria resposta ao universalismo da psicologia intercultural: a **psicologia da libertação** de Ignacio Martín-Baró, assassinado em El Salvador em 1989, cuja obra póstuma *Psicología de la liberación* (1998) acumula cerca de 1.380 citações — uma das maiores contagens de toda esta auditoria, comparável às da tradição anglófona. Martín-Baró propõe que a psicologia latino-americana abandone o papel de importadora de teorias e assuma como objeto a **realidade histórica da opressão**: o "contexto" deixa de ser variável de controle e passa a ser estrutura. Essa inflexão conecta-se à matriz filosófica da **colonialidade do poder** (Quijano), à noção de "dupla consciência latino-americana" como programa de psicologia descolonizada ([Gonçalves, 2016](#)) e à análise crítica da produção de conhecimento psicológico sob pensamento colonial ([Dimenstein et al., 2022](#)). Para a psicologia da migração internacional, a contribuição é direta: a migração Sul-Sul — haitianos, venezuelanos, africanos rumo ao Brasil — não pode ser lida apenas como "aculturação" entre culturas simétricas; é movimento dentro de uma hierarquia colonial global que atravessa tanto o migrante quanto a sociedade receptora.

6.3 O funil empírico: a psicologia da migração internacional no Brasil

A produção brasileira sobre migração internacional é tardia — a revisão sistemática de [Cruz & Peres \(2025\)](#) (*Psicologia: Teoria e Prática*, UFMS) localizou apenas 17 artigos publicados entre 2004 e 2020, com fluxos haitianos (35%) e africanos (25%) mais investigados, num contexto em que as solicitações de residência de

estrangeiros saltaram de ~105 mil (2010) para ~1,2 milhão (2020) — mas em consolidação acelerada, com três núcleos identificáveis:

a) O programa de Porto Alegre — o paradigma de Berry aplicado à migração Sul-Sul. O grupo de Alice Einloft Brunnet (UFRGS/PUCRS/HCPA) opera exatamente na interface entre psicologia intercultural global e migração internacional no Brasil: Brunnet et al. (2018) mediram prevalências entre haitianos no Rio Grande do Sul — TEPT em 9,1%, depressão em 10,6% e ansiedade em 13,6% (*International Journal of Social Psychiatry*); Brunnet et al. (2019) testaram o modelo bidimensional de aculturação de Berry nessa população, encontrando predomínio da orientação integrativa, associação entre assimilação e menor ansiedade, entre separação e maior depressão — e, achado contra-intuitivo, a **separação linguística associada a 76% mais chances de sintomas de ansiedade**, com o contato com a cultura de origem via língua funcionando como fator protetivo. A linha segue ativa com venezuelanos de primeira geração: Gil, Brunnet & Pizzinato (2026) (estudo longitudinal, $n = 59$) e Gil, Pizzinato & Brunnet (2026) ($n = 195$; preconceito percebido associado negativamente à qualidade de vida física, $\beta = -0,279$), num fluxo que já ultrapassou 640 mil entradas no Brasil. É a demonstração empírica do funil: instrumentos e hipóteses do paradigma global testados — e tensionados — no contexto brasileiro.

b) A clínica transcultural brasileira. Herdeira de Bastide e da etnopsicanálise francesa, consolidou-se em dispositivos e pesquisa clínica: a etnografia de Branco-Pereira sobre o refúgio em São Paulo (*Refuge in Brazil: An Ethnographic Approach*, 2021) e sua etnografia clínica sobre imigrantes-refugiadas, saúde mental, cultura e racismo em São Paulo (*Viajantes do tempo*, 2020); as notas autoetnográficas sobre o processo diagnóstico transcultural em um ambulatório psiquiátrico para imigrantes e refugiados em São Paulo (Carvalho et al., 2023, *Périplos*); a reflexão sobre o lugar do analista na clínica transcultural (Fachel, 2024); e a Clínica Transcultural da SBPSP (desde 2016). A contracorrente crítica é a análise da **medicalização** do sofrimento do migrante internacional — a transformação de questões sociais, políticas e culturais em diagnósticos individuais — documentada na revisão integrativa de Martinello, Matsue & Lutinski (2024) (*REMHU*): ecos brasileiros da divergência medida $\times$ interpretação descrita na seção 4.

c) Os serviços e a voz dos clínicos. Duden, de Smet & Martins-Borges (2022) documentaram as perspectivas de psicólogos que atendem refugiados no Brasil: xenofobia, racismo, violações de direitos e conflitos de adaptação cultural aparecem como fontes centrais de sofrimento pós-migratório — convergência direta com a evidência global de que a discriminação pesa tanto ou mais que o trauma pré-migratório. Já Bustamante, Leclerc et al. (2016) alertavam, antes da grande onda venezuelana, que era hora de preparar os serviços de saúde mental brasileiros para migrantes e refugiados — previsão confirmada pela Operação Acolhida em Roraima.

6.4 Síntese do funil: convergência, divergência e inflexão regionais

O aprofundamento regional revela que o funil não é apenas geográfico, mas **epistemologicamente produtivo**. Convergência: o grupo de Porto Alegre mostra que o paradigma de Berry *opera* no Brasil e gera dados comparáveis internacionalmente. Divergência: a clínica transcultural brasileira e a psicologia da libertação tensionam esse mesmo paradigma — a primeira pela via da singularidade clínica (Bastide–Devereux–SBPSP), a segunda pela via da estrutura colonial (Martín–Baró–Quijano). Inflexão: a virada decolonial global (seção 5, ponto 10) encontra na América Latina sua matriz teórica original, o que inverte a direção habitual do fluxo de teorias — o Sul não como destinatário, mas como produtor dos instrumentos críticos do campo. A pergunta que

emerge para a pesquisa futura: *em que medida a experiência brasileira de migração internacional Sul-Sul reformula os pressupostos universalistas do modelo de aculturação e do complementarismo clínico?*

Nota metodológica: auditoria e análise relacional baseadas em 20 rodadas de busca bibliométrica (Google Scholar via ferramenta acadêmica) realizadas em setembro de 2026, complementando as 13 rodadas do relatório principal — incluindo 6 rodadas dedicadas ao eixo América Latina–Brasil (seção 6). As contagens de citações são instantâneos dinâmicos e devem ser lidos como ordens de grandeza.